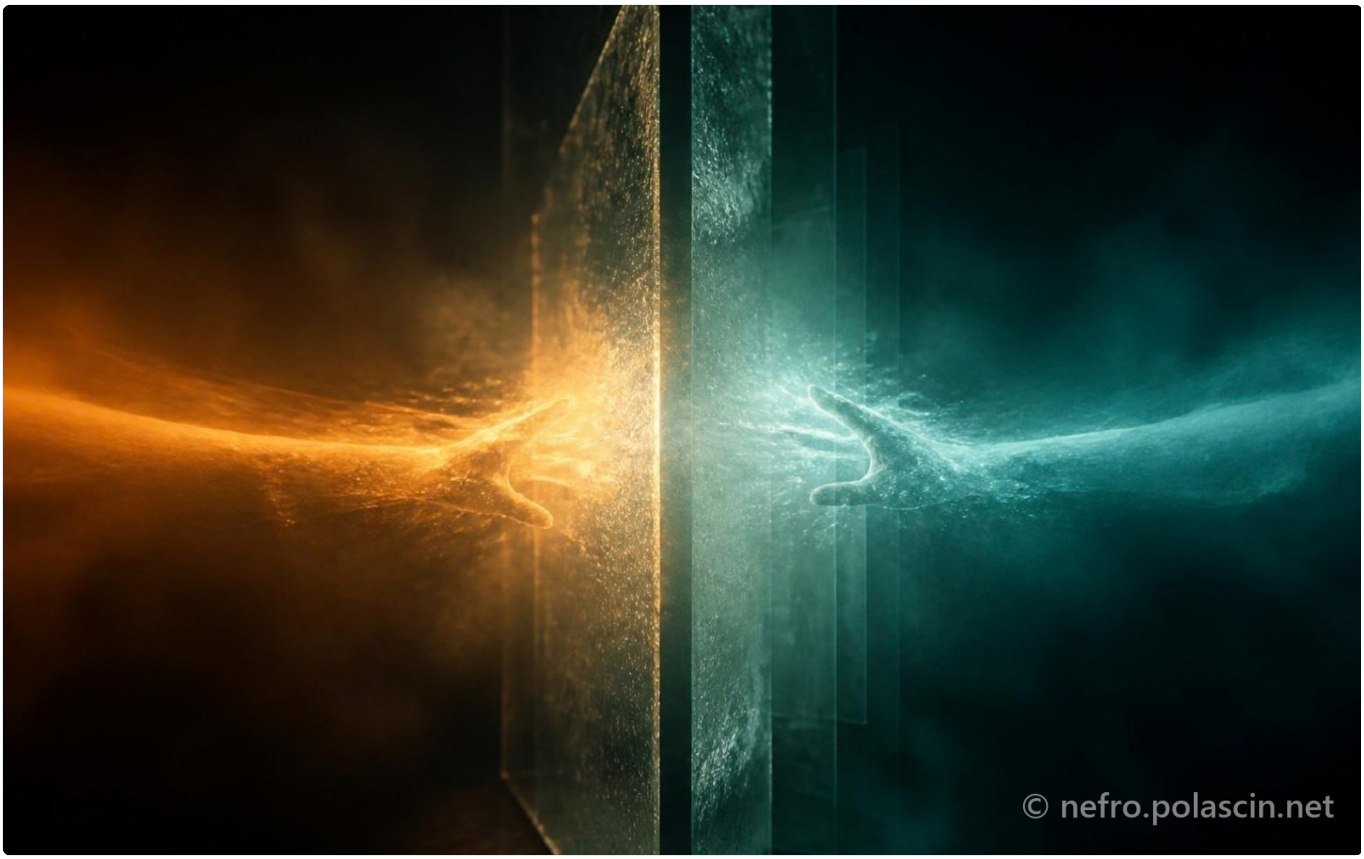
# Retatrutid a „pitting the physician against the patient“: bariéry procesu expanded access v praxi a význam pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026




Ilustračná scéna. Proces, ktorý má sprístupniť liečbu, dokáže postaviť lekára a pacienta proti sebe – hoci obaja mieria k tomu istému.

Komentár Caroline Messer na portáli Medscape nesie názov *Retatrutide: Pitting Physician Against Patient*. Nie je to správa o účinnosti molekuly a nie je to ani text o internetovom predaji neschválených peptidov. Ide o **procesný problém**: pacient podľa verejných kritérií výrobcu „spĺňa“ podmienky predschvaľovacieho prístupu k **retatrutidu**, no cesta k lieku vedie cez niekoľko nezávislých brán. Autorka to v americkom prostredí opisuje ako prekážku, ktorá môže postaviť lekára proti očakávaniu pacienta.

Tento článok oddeľuje **overiteľné fakty** (kto rozhoduje, aké formuláre a aké vstupné kritériá sú verejne uvedené) od **názoru** (či je administratívna záťaž neprimeraná a či vzťah lekár – pacient trpí). Opisuje **americký** režim *expanded access* („rozšírený prístup“) a výslovne ho **neprekladá 1 : 1** na Slovensko ani na EÚ. Od neregulovaného používania produktov označených ako retatrutid sa líši v jednom bode, na ktorom stojí celá téma: ide o **legálnu, ale úzku cestu k autentickému skúšanému lieku**, nie o obídenie regulácie.

## Čo retatrutid je – a čo zatiaľ nie je

Retatrutid (LY3437943) je **skúšaný** raz týždenne podávaný **trojitý agonista receptorov pre GIP, GLP-1 a glukagón**. Vo fáze 2 u dospelých s obezitou viedla 48-týždňová liečba k výraznému poklesu hmotnosti: pri dávke 12 mg bol priemerný pokles **24,2 %** oproti **2,1 %** pri placebe (Jastreboff a kol., *N Engl J Med* 2023; PMID 37366315). To je kontext účinnosti, nie dôvod predpisovať liek mimo schválenia. Retatrutid **nemá** v čase písania tohto textu schválenie FDA ani EMA na žiadnu indikáciu. Fáza 3 (programy TRIUMPH a TRANSCEND) prebieha; renálne ukazovatele v uvedenej fáze 2 **neboli primárnym cieľom** a tento článok z nich nevyvodzuje benefit pre chronickú chorobu obličiek (CKD).

Výrobca vo verejných materiáloch uvádza, že pre obmedzený počet pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá

a nemôžu vstúpiť do klinického skúšania, považuje za medicínsky primerané sprístupniť autentický retatrutid pred schválením FDA, v súlade s usmernením úradu. To je východisko komentára Medscape. Otázka nie je, či molekula „funguje“, ale **ako sa k nej pacient vôbec môže dostať**.

## Fakty: čo expanded access v USA znamená

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) označuje *expanded access* (často aj „compassionate use“) ako možnú cestu pre pacienta so **závažným alebo bezprostredne život ohrozujúcim** ochorením k **skúšanému** lieku mimo klinického skúšania, ak nie je k dispozícii porovnateľná uspokojivá liečba. Skúšaný produkt ešte **neprešiel** rozhodnutím FDA o bezpečnosti a účinnosti pre dané použitie; účinok u konkrétneho pacienta je neistý a môžu sa vyskytnúť neočakávané závažné nežiaduce účinky.

Pre individuálneho pacienta mimo naliehavej situácie FDA vo verejnej príručke pre lekárov uvádza tieto kroky:

1. **List splnomocnenia** (*Letter of Authorization*, LOA) od výrobcu, ktorý umožňuje FDA odkázať na už existujúcu žiadosť o skúšaný nový liek (IND) dodávateľa. Ak LOA nie je, treba predložiť dostatočné údaje o kvalite lieku.
2. **Podanie FDA:** prednostne zjednodušený **formulár FDA 3926** (individuálny pacient); naďalej je prípustný aj starší **formulár FDA 1571** (IND). Formulár 1571 ostáva povinný pri iných typoch expanded access (stredne veľká populácia, treatment IND) a pri podaniach komerčného sponsora.
3. **Schválenie inštitucionálnej etickej komisie** (IRB) podľa 21 CFR časť 56. Pri podaní cez formulár 3926 môže lekár požiadať o súhlas predsedu IRB alebo určeného člena namiesto zasadnutia pléna. Pri formulári 1571 treba na rovnakú výnimku samostatnú žiadosť o odpustenie.
4. **Informovaný súhlas** pacienta alebo zákonného zástupcu podľa 21 CFR časť 50, na formulári schválenom IRB.

Liečbu pri individuálnom IND mimo naliehavej situácie spravidla nemožno začať skôr, ako uplynie **30 dní** od doručenia podania FDA (alebo kým FDA skôr oznámi, že podanie nezdrží) **a** kým je k dispozícii súhlas IRB. FDA **nemôže prinútiť** výrobcu, aby liek dodal. Ochota výrobcu je preto praktickým predpokladom, nie formalitou. Toto uvádza priamo úrad, nie je to interpretácia komentára.

## Fakty: kto podľa Lilly a ClinicalTrials.gov spĺňa kritériá

Predschvaľovací individuálny prístup k retatrutidu je verejne evidovaný ako **NCT07629401** (*Pre-approval Expanded Access of Retatrutide*). Podľa záznamu musia byť splnené **všetky** tieto vstupné podmienky:

- vek **≥ 18** rokov;
- **refraktérna obezita** definovaná ako BMI **≥ 35 kg/m²** napriek dodržiavaniu a znášanlivosti liečby **najvyššou dostupnou dávkou** schválenej terapie chronického manažmentu hmotnosti;
- **dve alebo viac** závažných alebo život ohrozujúcich komplikácií obezity, pre ktoré pacient **aktuálne dostáva štandardnú starostlivosť**;
- **nemožnosť** účasti v prebiehajúcom klinickom skúšaní retatrutidu alebo porovnateľného skúšaného lieku (vstupné kritériá alebo chýbajúce primerane dostupné centrum);
- s pacientom boli v rámci spoločného rozhodovania prebraté **všetky štandardné možnosti** vrátane **bariatrickej chirurgie**.

Vylučovacím kritériom je medicínska kontraindikácia retatrutidu. Žiadosť podáva **ošetrujúci lekár**, nie pacient priamo výrobcovi. Lilly vo verejnej odpovedi pre zdravotníkov uvádza, že dostupnosť závisí od **geografie, zásob lieku a individuálneho posúdenia**; žiadosti hodnotí prípad od prípadu. Liek v tomto programe poskytuje **bezodplatne**. Po prípadnom schválení FDA a komerčnej dostupnosti sa expanded access ukončí.

Tieto body sú **vstupné sitá výrobcu**. Ani ich splnenie negarantuje dodávku. Až po súhlase výrobcu (LOA / ochota dodať) nasledujú FDA a IRB.

## Tri brány: čo je proces a čo je hodnotenie

Komentár Medscape zhŕňa cestu do **troch brán**: výrobca (LOA a dodávka), FDA (formulár 3926 alebo 1571) a IRB. Vo verejných dokumentoch FDA ide o **samostatné rozhodnutia rôznych subjektov**. Zamietnutie na

ktorejkoľvek bráne cestu zastaví. FDA neuvádza, že by výrobcu mohla k dodávke prinútiť, ani jednotný zákonný odvolací mechanizmus proti firemnému „nie“. To je faktické nastavenie systému. Tvrdenie, že proces „nemá nikoho, kto by za celok zodpovedal“, a že „nič sa nedá odvolať“, je už **hodnotenie autorky** – nie veta z 21 CFR.

Časové oneskorenie rádovo v **týždňoch až mesiacoch** komentár uvádza ako praktický dôsledok postupnosti krokov. Zákonná 30-dňová lehota FDA je len jednou zložkou; k nej sa pripočítava firemné posúdenie, príprava podania, IRB a logistika dodávky. Lilly vo všeobecnej politike expanded access sľubuje odpoveď lekárovi do **piatich pracovných dní** od prijatia žiadosti – to je firemný záväzok na komunikáciu, nie lehota na doručenie lieku pacientovi.

## Názor komentára: prečo „lekár proti pacientovi“

Messer opisuje situáciu, v ktorej pacient (a často aj rodina) vníma expanded access ako prísľub, kým lekár nesie **administratívnu, regulačnú a etickú záťaž** bez toho, aby mal v rukách jediného rozhodovateľa. Ak ktorákoľvek brána povie nie, vysvetlenie ostáva na klinickom lekárovi. To môže narušiť dôveru, aj keď lekár postupoval podľa pravidiel. Ide o **komentár z praxe**, nie o dôkaz, že retatrutid vzťah lekár – pacient poškodzuje farmakologicky. Kauzalitu lieku k tomuto napätiu článok **nepripisuje**.

Rovnako treba oddeliť túto cestu od čierneho trhu. Expanded access je pokus o **regulovaný** prístup k overiteľnému produktu. Nákup „retatrutidu“ z internetu je opak: bez identity látky, bez IND, bez IRB a bez farmakovigilancie. Tieto dve situácie sa v ambulancii môžu stretnúť u toho istého pacienta, ale medicínsky ani právne nie sú zameniteľné.

## Slovensko a EÚ: iný slovník, iné brány

Medscape opisuje **americký** individuálny IND. Na Slovensku formulár FDA 3926, LOA voči FDA ani americké IRB **neplatia**. Zámena týchto pojmov by v ambulancii škodila.

| Prvok | USA (FDA expanded access) | Slovensko / EÚ |
|---|---|---|
| **Názov cesty** | Expanded access (individuálny, stredne veľká populácia, treatment IND) | Terapeutické použitie neregistrovaného lieku; v EÚ navyše *compassionate use* (skupinový program) a named-patient (individuálne) |
| **Kto povoľuje liečbu** | FDA (IND) + IRB; výrobca musí liek dobrovoľne dodať | Ministerstvo zdravotníctva SR (§ 46 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.); ŠÚKL môže vydať stanovisko, pri nesúhlase MZ liečbu nepovolí |
| **Typický formulár** | FDA 3926 (alebo 1571) + LOA výrobcu | Žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; nie americký IND |
| **Súhlas pacienta** | Informovaný súhlas podľa 21 CFR časť 50, schválený IRB | Predchádzajúci písomný súhlas; je súčasťou zdravotnej dokumentácie |
| **Podmienka „nie je iná liečba“** | Kritériá 21 CFR 312.305; pri retatrutide navyše úzke sitá výrobcu (BMI ≥ 35 kg/m², dve závažné komplikácie, zlyhanie max. dávky schválenej liečby) | § 46 ods. 4: povoliť možno, ak nie je dostupný porovnateľný registrovaný humánny liek |
| **Skupinový program** | Intermediate-size / treatment IND alebo kohortový program výrobcu | § 46a liečebný program; v EÚ skupinový compassionate use podľa čl. 83 nariadenia (ES) č. 726/2004 – pravidlá určuje členský štát, EMA len odporúča |

EMA výslovne odlišuje **compassionate use** (program pre skupinu pacientov, ktorý členské štáty zavádzajú samy; CHMP môže vydať odporúčanie) od liečby na **named-patient** báze, pri ktorej lekár získava liek priamo od výrobcu pre konkrétneho pacienta a agentúru o tom informovať nemusí. Ani jedna z týchto ciest nie je kópiou formulára FDA 3926.

Na Slovensku je ťažiskom **§ 46 ods. 3 a 4** zákona o liekoch: terapeutické alebo diagnostické použitie pre jedného pacienta alebo skupinu pri ohrození života alebo riziku závažného zhoršenia stavu. Pri skúšanom lieku ide typicky o písmená týkajúce sa neregistrovaného alebo skúšaného humánneho lieku, nie o „off-label“ už registrovaného prípravku. Povoľuje **MZ SR** na žiadosť poskytovateľa, ktorý liečbu indikuje, ak nie je dostupný

porovnateľný registrovaný liek. ŠÚKL vo verejných pokynoch rieši najmä **hlásenie dovozu** neregistrovaných liekov po povolení MZ, nie vydávanie amerického IND. Výrobca musí liek aj tak **chcieť dodať**; geografické obmedzenie, ktoré Lilly uvádza pri retatrutide, preto ostáva praktickou bránou aj mimo USA.

Kritérium „nie je porovnateľný registrovaný liek“ je v EÚ/SR prísne v inom zmysle než americké sitá NCT07629401. V SR sú na obezitu a diabetes 2. typu dostupné schválené inkretínové lieky. Ani ťažká, na schválenú liečbu refraktérna obezita **automaticky** nezakladá nárok na retatrutid cez § 46. Tvrdosť tejto vety je zámer: falošná nádej škodí rovnako ako mlčanie o existencii cesty.

## Prečo to v nefrológii nie je okrajová téma

Pacient s obezitou, diabetom 2. typu, hypertenziou a CKD – teda s kardiorenálno-metabolickým (CKM) syndrómom – je práve ten, kto môže mať zo zníženia hmotnosti a zlepšenia metabolického profilu najviac. Zároveň je to pacient, ktorého obezitologické a diabetologické skúšania **často vylučujú** pre eGFR, proteinúriu, dialýzu alebo komplexnú komedikáciu. Ak sa do skúšania nedostane, expanded access môže byť *jedinou regulovanou* cestou k skúšanému retatrutidu. Môže byť aj cestou, ktorá sa na tretej bráne zastaví.

Kým proces beží, liečba je **štandardná starostlivosť**: schválené antiobezitiká a antidiabetiká v indikácii a dávke, inhibítory SGLT2 a blokáda RAAS podľa KDIGO, kontrola tlaku, objemu a výživy, prípadne bariatrická chirurgia tam, kde je indikovaná a dostupná. Čakanie mesiacov nie je „prázdne miesto“, v ktorom treba vymyslieť dávku neschváleného lieku. **Schválené dávkovanie retatrutidu pre CKD neexistuje** – a tento text ho nevymýšľa. Údaje o obličkových výsledkoch sa v programe výrobcu ešte len zbierajú; kým nie sú publikované primárne cieľové ukazovatele, nefrológ z nich nemá vyvodzovať indikačný záver.

Ak by sa regulovaný prístup predsa len otvoril, platia rovnaké klinické obavy ako pri iných silných inkretínových liekoch: nauzea, vracanie a znížený príjem tekutín môžu u pacienta s CKD spustiť hypovolémiu a akútne poškodenie obličiek, najmä pri diuretikách a RAAS blokáde. To je riziko triedy a klinickej situácie, nie dôkaz, že retatrutid obličky poškodzuje. Monitorovanie a pauza pri akútnom ochorení ostávajú súčasťou štandardnej starostlivosti, nie experimentálnym protokolom z tohto článku.

## Čo z toho plynie pre prax

- Ak pacient žiada „retatrutid teraz“, najprv rozlíšte **skúšanie**, **expanded access / terapeutické použitie** a **neregulovaný produkt**. Ide o tri odlišné situácie.
- V USA je expanded access k retatrutidu úzka, verejne opísaná cesta (NCT07629401) s troma bránami. Lekár je žiadateľ, nie výdajňa.
- Na Slovensku hľadajte analogickú, nie identickú cestu: klinické skúšanie, prípadne § 46 / § 46a, vždy s ochotou výrobcu dodať liek. Neexistuje slovenský „formulár 3926“ na retatrutid.
- Kým liek nie je schválený, jedinou správnou liečbou ostáva **dostupná schválená terapia** a znižovanie rizika. Falošný pocit, že „už len čakáme na zásielku“, nesmie odsunúť titráciu toho, čo pacient môže dostať dnes.
- Názor, že proces stavia lekára proti pacientovi, berte ako upozornenie pre komunikáciu s pacientom: sľubujte postup a časový rámec, nie výsledok tretej brány.

Retatrutid môže po dokončení vývoja a posúdení regulátorov rozšíriť možnosti liečby obezity. Kým sa tak stane, expanded access nie je skratkou namiesto schválenia. Je to úzka, dobrovoľná a viacbránová výnimka – v USA opísaná inak ako v EÚ a na Slovensku. Pre nefrológa je užitočné vedieť, *že* existuje, *kde* sa končí a *čím* medzitým pacienta liečiť.

---

***Zdroj:*** *Messer C. Retatrutide: Pitting Physician Against Patient. Medscape Gastroenterology. 19. augusta 2026. medscape.com.*

***Ďalšie zdroje:*** *U.S. Food and Drug Administration. Expanded Access. fda.gov; FDA. For Physicians: A Guide to Non-emergency Single Patient Expanded Access Submissions. fda.gov; ClinicalTrials.gov. NCT07629401 – Pre-approval Expanded Access of Retatrutide (LY3437943). clinicaltrials.gov; Eli Lilly and Company. Is there an expanded access program for retatrutide? medical.lilly.com; Európska lieková agentúra. Compassionate use. ema.europa.eu; Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, § 46 a § 46a. zakonypreludi.sk;*

*ŠÚKL. Hlásenie dovozu neregistrovaných liekov na základe povolenia MZ SR. sukl.sk; Jastreboff AM, et al. Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity – A Phase 2 Trial. N Engl J Med. 2023;389(6):514–526. PMID: 37366315.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=retatrutid-expanded-access-lekar-pacient-bariery · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.